

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Prostatectomy (Radical)

الإستئصال الجذري لغدة البروستاتا

A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required? ☐ Yes ☐ No
If Yes, is an Interpreter present? ☐ Yes ☐ No

B. Condition and treatment

The doctor has explained that you have the following condition: (Doctor to document in patient's own words)

This condition requires the following procedure. (Doctor to document - include site and/or side where relevant to the procedure)

The following will be performed:

A Prostatectomy is the surgical removal of all or part of the prostate gland.

A vasectomy is routinely done because the vas tube drains into the prostate.

C. Risks of a prostatectomy (radical)

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following:

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need

أ. المترجم / الاحتياج الثقافي

هل توجد حاجة لخدمات الترجمة ؟ ☐ نعم ☐ لا
إذا كانت الإجابة بنعم ، هل هناك مترجم حاضراً ؟ ☐ نعم ☐ لا

ب . الحالة المرضية والعلاج

لقد قام الطبيب بشرح حالتك المرضية لك وأنت تعاني من : (يقوم الطبيب بالتوثيق بما يلائم لغة ومفردات المريض)

تتطلب هذه الحالة المرضية الإجراء التالي:
(يقوم الطبيب بالتوثيق – يشمل ذلك موضع و/أو الجهة المتعلقة بالإجراء)

سيتم القيام بالتالي :

استئصال غدة البروستاتا هو إزالة كامل أو جزء من غدة البروستاتا .

من المعتاد إزالة القناة الدافقة لأن أنبوب القناة الدافقة يصرف محتوياته في غدة البروستاتا .

ج. مخاطر الاستئصال الكامل (الجذري) لغدة البروستاتا

هذا الإجراء له مخاطر ومضاعفات ، وهي تشمل ، ولكنها غير مقتصرة على الآتي:

مخاطر عامة:

- قد تحدث عدوى ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى .
- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايبييردامول (بيرسانتن أو اساسانتن).
- قد يحدث انهيار (انطباع) لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بعدوى في الصدر ، وقد يتطلب علاج ذلك

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

antibiotics and physiotherapy.

- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- Bleeding during the operation, which may require a blood transfusion.
- It is likely you will have difficulty with getting an erection due to nerve damage from the surgery. This may recover and can usually be treated with medication if the problem persists. Sexual will feel different after the operation.
- Some urinary incontinence is common after surgery. You will probably need to use a pad after catheter removal though urinary control usually improves with time.
- You will not ejaculate. The operation will result in infertility.
- Injury to the rectum or ureters may occur during the operation. Further surgery may be needed to repair the injury. There is a small possibility of a temporary or permanent stoma bag.
- Late bleeding can occur up to three weeks after the operation from where the prostate was removed. This may result in blood in the urine and even blockage of the urine flow.
- Bladder muscle weakness can rarely result in the inability to pass urine. The catheter may need to be re-inserted to allow the bladder muscles recover.
- Swelling and pain in the testicles can occur due to inflammation. Treatment is usually rest and supportive underwear.

- استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- عند أصحاب الأوزان الزائدة ، تزداد مخاطر الإصابة بعدوى والتهاب الجرح والصدر ، مضاعفات في القلب والرئة ، وجلطات الأوعية الدموية.
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مما يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد يفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر محددة:

- النزيف أثناء الجراحة مما قد يتطلب نقل الدم .
- من المرجح أن تكون هناك صعوبة في الحصول على انتصاب بسبب ضرر يصيب العصب أثناء الجراحة . قد يتم شفاء ذلك ، ويمكن علاجه عادةً بالأدوية إذا استمر وجود المشكلة يحدث اختلاف في الشعور بالنشوة الجنسية (ذروة العلاقة الجنسية) وفي النشاط الجنسي.
- حدوث شيء من سلس البول يعتبر من الأمور الشائعة بعد الجراحة. قد يكون المريض بحاجة لاستخدام الحفاضات بعد إخراج القسطرة ، بالرغم من تحسن القدرة على السيطرة على خروج البول مع الوقت.
- لا يحدث القذف . تسبب الجراحة حدوث العقم.
- قد تحدث إصابة للمستقيم أو الحالبين أثناء العملية. قد يتطلب الأمر جراحة أخرى لإصلاح الضرر . هناك احتمال ضئيل بأن يتم تحويل البراز ليخرج عن طريق فتحة خارجية مؤقتة أو دائمة للأمعاء متصلة بكيس لتجميع البراز .
- قد يحدث نزيف متأخر من منطقة استئصال غدة البروستاتا و قد يستمر حتى الأسبوع الثالث بعد العملية ، وقد يؤدي إلى وجود الدم في البول ، بل وحتى إلى انسداد تدفق البول.
- ضعف في عضلة المثانة البولية والذي نادراً ما يسبب عدم القدرة على إخراج البول. قد تكون هناك حاجة لإعادة إدخال القسطرة لحين إعطاء فرصة لعضلة المثانة للشفاء.
- تورم و ألم في الخصيتين بسبب الالتهاب . يكون العلاج عادةً بخلود المريض للراحة وارتداء الملابس الداخلية الداعمة.
- تسرب البول : قد يتسرب البول من منطقة الاتصال بين المثانة

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- A urinary leak can occur at the join between the bladder and the urethra. This will often seal itself but may require a further operation.
- A stricture (scar causing narrowing) can develop between the urethra and the bladder. This may need to be repaired by another operation.
- Despite visual clearance, the cancer may recur locally or elsewhere in your body.
- Death due to complications after radical prostatectomy is about 1 in 200 cases.

D. Significant Risks and Procedure Options

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

E. Risks of not having this procedure

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

F. Anesthetic

This procedure may require an anesthetic. (Doctor to document type of anesthetic discussed)

G. Patient Consent

I acknowledge that the doctor has explained;

- My medical condition and the proposed procedure, including additional treatment if the doctor finds something unexpected. I understand the risks, including the risks that are specific to me.

البولية والإحليل. عادةً ما يحدث انغلاق تلقائي للمنطقة ، ولكنه قد يتطلب جراحة أخرى.

- قد يحدث تضيق (حدوث ضيق بسبب الندب) بين الإحليل والمثانة البولية. قد يتطلب ذلك الإصلاح بجراحة أخرى.
- بالرغم من استئصال كل السرطان الذي تمت رؤيته أثناء الجراحة ، إلا أن السرطان قد يعود إما بشكل موضعي أو في منطقة أخرى من الجسم.
- الوفاة بسبب المضاعفات بعد إجراء الاستئصال الكامل لغدة البروستاتا يحدث عند 1 من بين كل 200 مريض.

د . مخاطر كبيرة وهامة وخيارات الإجراء

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

هـ . مخاطر عدم الخضوع للإجراء
(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

و . التخدير
قد يتطلب القيام بهذا الإجراء الخضوع للتخدير. (يقوم الطبيب المعالج بتدوين نوع التخدير الذي تمت مناقشته مع المريض)

ز . إقرار المريض
أقر بأن الطبيب قد شرح لي :
• حالتي المرضية والإجراء المقترح ، بما في ذلك الإجراءات العلاجية الإضافية في حالة اكتشاف الطبيب لأمر لم يكن متوقعاً .
أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- The anesthetic required for this procedure. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- Other relevant procedure/treatment options and their associated risks.
- My prognosis and the risks of not having the procedure.
- That no guarantee has been made that the procedure will improve my condition even though it has been carried out with due professional care.
- The procedure may include a blood transfusion.
- Tissues and blood may be removed and could be used for diagnosis or management of my condition, stored and disposed of sensitively by the hospital.
- If immediate life-threatening events happen during the procedure, they will be treated based on my discussions with the doctor or my Acute Resuscitation Plan.
- A doctor other than the Consultant may conduct the procedure. I understand this could be a doctor undergoing further training.

I have been given the following Patient Information Sheet/s:

- ☐ About Your Anesthetic
- ☐ Epidural & Spinal Anesthetic
- ☐ Prostatectomy (Radical)
- ☐ Blood and Blood Products Transfusion

- I was able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the proposed procedure and its risks, and my treatment options. My questions and concerns have been discussed and answered to my satisfaction.
- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this form but, preferably following a discussion with my doctor.
- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during my procedure

• التخدير المطلوب لهذا الإجراء. أقر بأنني أتفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.

• الخيارات الإجرائية الطبية \العلاجية الأخرى ذات الصلة والمخاطر المترتبة عليها.

• المسار الطبيعي لحالتي المرضية ومخاطر عدم القيام بالإجراء.

• عدم تقديم أي ضمانات لي بأن الإجراء سيؤدي إلى تحسن حالتي المرضية بالرغم من أن الإجراء سيتم بمهنية عالية.

• قد يشتمل الإجراء نقل دم لي .

• احتمالية إزالة أنسجة أو دم ، وقد يستخدمان في تشخيص أو علاج حالتي المرضية ويتم حفظها والتخلص منها عن طريق المستشفى بطريقة مهنية تراعي الأنظمة والأعراف.

• إذا حدث (لا سمح الله) ما يهدد حياتي أثناء الإجراء ، فسيتم التعامل معه حسب ما تم شرحه لي من قبل الطبيب أو حسب خطة الإنعاش المحددة لي .

• قد يقوم بالإجراء طبيب آخر غير الاستشاري ، وأنا مدرك تماماً أن هذا الطبيب منخرط في برنامج تدريبي متقدم.

لقد تم إعطائي مستندات وأوراق المعلومات التالية:

- نوعية التخدير المقدم لي
- التخدير النصفي (التخدير الشوكي و تخدير فوق الجافية)
- الاستئصال الكامل (الجزري) لغدة البروستاتا
- نقل الدم ومشتقات الدم لي

• منحت لي الفرصة من قبل طبيبي لطرح أسئلتي والتعبير عن مخاوفي فيما يخص حالتي المرضية والإجراء المقترح ومخاطره ، والخيارات المتوفرة لعلاجي. وقد تم الرد على استفساراتي ومخاوفي بما حقق لي الرضا.

• أتفهم أن من حقي تغيير رأيي في أي لحظة حتى ولو حدث ذلك بعد توقيع لي لهذا النموذج ، ولكن من الأفضل أن يتم ذلك بعد مناقشته مع طبيبي.

• أتفهم أنه قد يتم خلال الإجراء أخذ صور طبية أو تسجيل مقاطع فيديو تخص المرض وذلك كجزء من الإجراء وأن ذلك

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.

On the basis of the above statements,

I request to have the procedure

Name of Patient:

Signature:

Date:.....Time:.....

Patients who lack capacity to provide consent

Consent must be obtained from a substitute decision maker/s in the order below.

Name of Substitute

Decision Maker/s:

Signature:

Relationship to patient:

Date:.....Time:.....

Contact No:.....

H. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent section (G) and I am of the opinion that the patient/substitute decision-maker has understood the information.

Name of

Doctor/delegate:

Designation:

Signature:

Date:.....Time:.....

Witnesses (for the above signature)

1) Name:..... Signature:

Date:.....Time:.....

2) Name:..... Signature:

Date:.....Time:.....

سيتم خلاله، وأن هذه الصور والمقاطع المصورة ستساعد الطبيب على اختيار أنسب طرق العلاج.

وبناء على ما تقدم، فإنني أطلب الخضوع للإجراء الطبي

اسم المريض :

التوقيع :

التاريخ : الوقت:

المرضى فاقد القدرة على إعطاء الإقرار
يتم الحصول على الإقرار من قبل شخص/ أشخاص بديل مناسب ينوب عنه ويملك المقدرة على اتخاذ القرار على النحو الموضح أدناه.

اسم من ينوب/ينوبون عن المريض في اتخاذ القرار :

التوقيع :

صلته بالمريض :

التاريخ : الوقت:

رقم الإتصال:

ح . بيان الطبيب / مندوب الطبيب
لقد شرحت للمريض كل النقاط المذكورة سابقاً في قسم إقرار المريض (ز) ، وأنا على ثقة بأن المريض / من ينوب عنه قد فهم جميع المعلومات المقدمة له .

اسم الطبيب/ مندوب الطبيب:

طبيعة الإنابة :

التوقيع :

التاريخ : الوقت:

توقيع الشهود :

1) الاسم: _____ التاريخ:

التوقيع: _____ الوقت :

2) الاسم: _____ التاريخ:

التوقيع: _____ الوقت :

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____